Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana

Rua General Hipólito, 3392 - Bairro: São João - CEP: 97502441 - Fone: (55)3029-9999 - Balcão Virtual: (55)99735-7945 - Email: fruruguaia1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5016098-33.2022.8.21.0037/RS

AUTOR: JOAO BATISTA VILASNOVA DE SOUZA
ADVOGADO(A): DANIEL CHARAO (OAB RS108715)

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

JOAO BATISTA VILASNOVA DE SOUZA ajuizou ação de obrigação de fazer em face de **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS**, ambos qualificados nos autos. Relatou ser portador de neoplasia pulmonar CID10 - C18.7 - EC IV com metástases pulmonares, possuindo mutação do gene KRAS o que lhe confere resistência a tratamentos direcionados a via do EGFR. Referiu que necessita de tratamento com os medicamentos FOLFIRI (FLUORACIL, LEUCOVORIN e IRINOTECANO) + BEVACIZUMABE, cujo protocolo consiste nas medicações FLUORACIL na dose de 5.600mg, LEUCOVORIN na dose de 800 mg, IRINOTECANO na dose de 360mg e BEVACIZUMABE na dose de 575 mg a cada 14 dias, sendo o custo por aplicação em torno de 22.244,03. Disse que, diante de sua condição de usuário do IPÊ-Saúde, vinculado ao IPERGS, do qual é segurado, foi formulou pedido de fornecimento da medicação junto a esta autarquia, sendo indeferido. Discorreu sobre a urgência no início do tratamento. Falou sobre o custo do medicamento. Diante do exposto, requereu, em juízo de cognição sumária, e ao final, o fornecimento do tratamento postulado. Pugnou pela concessão de gratuidade de justiça. Instruiu a inicial com documentos (evento 1, INIC1).

Concedidos à parte autora o benefício da gratuidade de justiça e a tutela de urgência pleiteada (evento 3, DESPADEC1).

O requerido ofertou contestação. Discorreu sobre o tratamento oncológico no IPE-Saúde. Alegou que a pretensão da parte autora é ilegal porque os fármacos postulados não integram a tabela de cobertura do IPE-Saúde. Discorreu sobre a necessidade de correspondência entre fonte de custeio e amplitude de benefícios. Aduziu que a intervenção do Juízo afronta os princípios da igualdade, da legalidade e da independência e harmonia entre os poderes, bem como que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, porquanto não se está diante de relação contratual de consumo, mas de assistência à saúde submetida às normas de direito público. Requereu a improcedência do pedido (evento 21, CONT1).

Houve réplica (evento 24, RÉPLICA1).

As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (evento 42, PET1 e evento 45, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (evento 51, PROMOÇÃO1).

A seguir, vieram os autos conclusos para julgamento.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora requer a condenação do réu ao fornecimento do tratamento com o uso dos fármacos FOLFIRI (FLUORACIL, LEUCOVORIN e IRINOTECANO) + BEVACIZUMABE, cujo protocolo consiste nas medicações FLUORACIL na dose de 5.600mg, LEUCOVORIN na dose de 800 mg, IRINOTECANO na dose de 360mg e BEVACIZUMABE na dose de 575 mg a cada 14 dias, a fim de tratar a moléstia que lhe acomete.

Destaca-se que a obrigação no fornecimento do tratamento de saúde ora perseguido pela parte autora decorre da Constituição da República.

Incontroverso nos autos que o autor é filiado ao Ipê-Saúde, assim como que acometido de neoplasia pulmonar CID10 - C18.7 - EC IV com metástases pulmonares.

O artigo 2º da Lei Complementar 12.134/2004, em vigor quando do ajuizamento da ação, dispunha que:

> *"Art. 2º - Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde."*

Desta feita, como se verifica da análise do referido artigo, resta presente a responsabilidade do IPERGS/IPE-SAÚDE em fornecer o atendimento médico e hospitalar, assim como praticar os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento.

Cumpre registrar que, em 06/04/2018, entrou em vigor a Lei Complementar n.° 15.145/2018 - que revogou a Lei Complementar n.º 12.134/2004 - dispondo sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde e excluindo da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º). Veja-se:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*
>
> *§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.*

Contudo, a ausência de previsão do medicamento no protocolo do plano de saúde não pode ser suficiente para excluir o direito da autora ao tratamento prescrito como sendo o mais adequado ao seu diagnóstico.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido da impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONSIDERAÇÕES. 1. DO DIREITO AO TRATAMENTO. A necessidade do tratamento de saúde está comprovada nos autos, bem como a filiação da parte autora perante o IPÊ-SAÚDE. Subsunção, in casu, dos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar/RS n. 15.145/2018. 2. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. É de preservação dos direitos fundamentais que se trata, evitando-se o seu esvaziamento em decorrência de restrições descabidas, desnecessárias ou desproporcionais. 3. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS PELA AUTARQUIA ESTADUAL. O argumento de que o tratamento não pode ser concedido em razão de não constar nos atos normativos editados pelo IPÊ-SAÚDE não prevalece diante do princípio constitucional da legalidade, pois ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, inciso II, da CF/1988).* ***A lei estadual não exclui a responsabilidade do plano de saúde de custear tratamento oncológico ao segurado, que contribui mensalmente para receber a assistência quando precisar. Limitações abusivas não prevalecem diante das normas constitucionais que garantem o direito à vida.*** *4. DO BLOQUEIO DE VALORES. Tratamento de saúde com custo elevado. Bloqueio de valores na conta do IPÊ-SAÚDE. Necessidade de três orçamentos. Observância daquele de menor valor. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50013496620158210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 12-05-2023) Grifei.*
>
> *APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) E AXITINIBE (INLYTA) PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. Apelo da parte autora: Hipótese dos autos em que o recurso da parte autora versa exclusivamente acerca da majoração dos honorários sucumbenciais. O procurador da parte autora não é beneficiário da gratuidade judiciária, não efetuou o preparo no ato da interposição da apelação (art. 99, §5º, do CPC), tampouco atendeu à determinação para proceder ao pagamento em dobro, na forma do art. 1007, §4º, do CPC/15. Nesse contexto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade, imperioso não conhecimento do recurso, porquanto deserto. Apelo da Autarquia: Fornecimento de medicamentos fora dos protocolos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento da autarquia previdenciária não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários.* ***Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento dos medicamentos ora solicitados, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia ao fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas.*** *APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50090431620218210021, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 15-12-2022). Grifei.*

Aliado a isso, a Resolução n.º 21/79 (**http://www.ipe.rs.gov.br/upload/1398259973_RESOLU%C3%87%C3%83O%2021%2079%20II.pdf**) também prevê que "*o Plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento*", inclusive em área oncológica:

> *Artº 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades: Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia,* ***Oncologia****, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia. - grifei*

Ademais, os laudos médicos acostados aos autos (evento 1, RECEIT9 e evento 1, OUT10), revelam a evolução da patologia que acomete a parte autora e a ineficácia do tratamento alternativo, demonstrando a necessidade dos medicamentos prescritos de acordo com o quadro de saúde apresentado pela paciente.

Confira-se (evento 1, RECEIT9):

Relatório Médico

João Batista Vilasnova Souza, 61 anos, portador de patologia CID 10 – C18.7, EC IV. Diagnóstico da doença em 23/03/2020. Possui metástases pulmonares.

Paciente submetido a tratamento cirúrgico em 23/03/2020. Após realizou quimioterapia adjuvante com o protocolo Roswell-Park por 6 meses. Evoluiu com metástases hepáticas, que foram ressecadas em 05/05/2021. Após a ressecção das metástases hepáticas recebeu mais 6 meses de quimioterapia com o protocolo mFOLFOX6.

Exames de reestadiamento mostram progressão de doença em pulmão. Possui doença KRAS selvagem, logo tem indicação de receber tratamento com o protocolo FOLFIRI + bevacizumabe. O protocolo consiste nas medicações fluouracil na dose de 5.600 mg, leucovorin 800 mg, irinotecano 360 mg e bevacizumabe 575 mg a cada 14 dias.

Estudos que comprovam a eficácia da medicação bevacizumabe associado ao protocolo FOLFIRI: J Clin Oncol 26:689, 2008; J Clin Oncol 23:3502, 2005.

.

O não uso da medicação coloca a vida do paciente em risco de morte. O não uso da medicação compromete o tratamento da paciente, reduzindo suas chances de resposta, sobrevida livre de progressão e tempo de sobrevida.

E, não obstante os medicamentos não estejam elencados no protocolo do plano de saúde, este não se exime da obrigação de fornecê-los, pois o direito constitucional à saúde não pode ser limitado a uma tabela ou protocolo.

Portanto, evidenciado o direito da parte autora, enquanto beneficiária, de postular ao IPERGS/IPE-Saúde o fornecimento da medicação necessária ao tratamento de sua patologia mesmo que o fármaco não integre seus protocolos ou listas, porquanto se trata de medicamento que é indispensável à manutenção da sua saúde.

Nesses termos, impositiva a procedência, para que seja o requerido compelido a fornecer à parte autora o tratamento postulado, tornando-se definitiva a liminar deferida.

No tocante ao arbitramento dos honorários, considerando que se trata de ação que envolve direito à saúde, matéria cuja natureza não é de grande complexidade, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (**TEMA 1076**), firmou a seguinte tese:

> *i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.*
>
> *ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.*

Com efeito, no caso em apreço, considerando o alto valor atribuído à causa e sua baixa complexidade, desproporcional a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, devendo esta ser feita de forma equitativa porquanto inestimável o proveito econômico da demanda, já que se trata de ação na qual o pleito é, em suma, o fornecimento de tratamento medicamentoso e a garantia do direito à vida e à saúde da parte autora.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **JOAO BATISTA VILASNOVA DE SOUZA** ajuizou ação de obrigação de fazer em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, para tornar definitiva a liminar deferida e determinar ao requerido que providencie o tratamento recomendado com os medicamentos **FOLFIRI (FLUORACIL, LEUCOVORIN e IRINOTECANO) + BEVACIZUMABE, cujo protocolo consiste nas medicações FLUORACIL na dose de 5.600mg, LEUCOVORIN na dose de 800 mg, IRINOTECANO na dose de 360mg e BEVACIZUMABE na dose de 575 mg a cada 14 dias**, sob pena de custeio do tratamento necessitado, mediante bloqueio de valores.

Isento o Estado do pagamento das custas judiciais (art. 11, parágrafo único, da Lei n.º 8.121/85), bem como da taxa judiciária e sua respectiva guia (Ofício Circular 003/2014-CGJ), pois o processo tramitou em cartório estatizado.

Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais, excetuadas eventuais despesas com condução do Oficial de Justiça (art. 6°, letra "c" da Lei n° 8121/85 e Ofício Circular 003/2014-CGJ).

Por outro lado, conforme fundamentação supra, condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais na quantia de R$ 1.500,00 ao procurador da parte autora, ora fixados levando em conta os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2°e 8° do Código de Processo Civil. *Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, conforme art. 507 da Consolidação Normativa Judicial (Provimento nº 014/2022 – CGJ), a partir da presente decisão até o trânsito em julgado, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.*

Publicação, registro e intimações agendados eletronicamente.

Em caso de interposição de **apelação**, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso seja suscitado, pela parte recorrida, em preliminar de contrarrazões, inconformismo contra decisões proferidas na fase de conhecimento não submetidas a agravo de instrumento, intime-se o recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas, nos termos do art. 1.009, §2 º, do CPC.

Após, ao Ministério Público.

A seguir, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com retorno dos autos, intimem-se as partes e/ou transitada em julgado a presente decisão, nada sendo requerido, recolhidas eventuais custas pendentes ou adotadas as providências para sua cobrança administrativa, **arquivem-se.**

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BALICKI, Juiz de Direito**, em 12/6/2024, às 17:12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10061065155v12** e o código CRC **f53f4a97**.